कुराकानीको विषय: घर फर्कने, सर्ने वा पर्खने

मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार (PFA) को तालिम लिएका, सुपरिवेक्षक भएका र प्रेषण (रेफरल) को बाटो थाहा भएका व्यक्तिहरूका लागि ।



तत्काल खतरा छ? सत्र रोक्नुहोस्, त्यो व्यक्तिसँगै बस्नुहोस् र अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस् । उहाँलाई एक्लै नछोड्नुहोस् । स्वास्थ्यकर्मी वा उद्धारकर्मीले जिम्मा नलिँदासम्म साथमै रहनुहोस्; अलि शान्त महसुस हुनु अन्तिम बिन्दु होइन । पूरा प्रक्रिया र सम्पर्क: पृष्ठ २ ।



पोस्टर A3



पर्चा, तीन पट्ट

तपाईंका सामग्रीहरू

पोस्टर · सबैको साझा ध्यान

समूहका लागि: छलफल सुरु गर्न, मानिसहरूले देखेका कुरा सोध्न र मुख्य सन्देशमा फर्कन प्रयोग गर्नुहोस् । सबैले देख्न सक्ने बनाउनुहोस्; हरेक लाइन ठूलो स्वरमा नपढ्नुहोस् ।

पर्चा · घर लैजाने विस्तृत जानकारी

कुनै प्रश्न आएमा वा नजिकबाट हेर्न, र आफूसँग राख्न वा अरूलाई दिन । सम्बन्धित भाग मात्र खोल्नुहोस्, जस्तै परिवारको अवस्थासँग मिल्दो बाटो, र सँगै पढ्ने प्रस्ताव गर्नुहोस् ।

एउटा वा दुवै सामग्री, जुनसुकै क्रममा प्रयोग गर्नुहोस् । दुवै सामग्री सक्नेमा होइन, मानिसलाई के चाहिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुहोस् ।

मानिसहरू आउनुअघि

- ☐ ताजा स्थानीय जानकारी जाँच्नुहोस्: घरको सुरक्षा जाँच, सहायता र चेतावनीबारे कसलाई सोध्ने, र उहाँहरूलाई कहिले भेट्न सकिन्छ । वडा कार्यालयले गर्ने काम क्षेत्रअनुसार फरक हुन्छ; स्थानीय रूपमा पुष्टि गर्नुहोस् ।
- ☐ पृष्ठ २ मा सहयोग सम्पर्कहरू भर्नुहोस् र जाँच्नुहोस् । सबैले देख्ने ठाउँमा पोस्टर टाँस्नुहोस्; पर्याप्त पर्चा ल्याउनुहोस् । सत्रपछि निजी कुराकानीका लागि समय छुट्याउनुहोस् ।
- ☐ भाषा र पहुँचको योजना बनाउनुहोस्: सरल शब्द, ठूला अक्षर, थप समय, वा आवश्यक र उपलब्ध भए साङ्केतिक भाषा दोभाषे । चित्र वा लेख बुझ्न वा हेर्न कठिन भए अरू विकल्प दिनुहोस् ।

सत्र करिब १५ मिनेट · योजना पूरा गर्न कसैलाई हतार नगराउनुहोस्, तत्काल सहयोगमा ढिलाइ नगर्नुहोस्

उद्देश्य: हरेक परिवारले आफ्नो अर्को कदमबारे सोचोस्, जाँच गरिएको जानकारी कहाँ सोध्ने थाहा पाओस्, र सहयोग कहाँ पाइन्छ थाहा पाओस् ।

1 स्वागत र उद्देश्य बताउने · २ मिनेट · कुनै पनि सामग्री

गर्नुहोस् आफ्नो परिचय दिनुहोस् र विषय बताउनुहोस् । सहभागिता स्वैच्छिक हो । कसैले आफू कहाँ जाँदैछ वा किन भनेर बताउनुपर्दैन ।

भन्नुहोस् *"हरेक परिवारको अवस्था फरक हुन्छ । आज हामी, तपाईं जहाँ भए पनि, केले सहयोग गर्न सक्छ भनेर कुरा गर्नेछौं ।"*

2 सँगै चित्र हेर्ने · ३ मिनेट · उपयोगी भए पोस्टर

गर्नुहोस् तीनवटा परिवार देखाउनुहोस्: घर फर्किँदै, नयाँ ठाउँमा सर्दै, अझै पर्खँदै । आफ्नो अवस्थासँग कुन मिल्छ भनेर, चाहे मनमनै, छान्न दिनुहोस् । पर्चा मात्र भए त्यसका तीनवटा बाटो प्रयोग गर्नुहोस् ।

सोध्नुहोस् *"चित्रको कुन परिवार अहिले तपाईंको परिवारसँग सबैभन्दा मिल्छ?"*

3 भावनाहरू · ३ मिनेट · कुनै पनि सामग्री

गर्नुहोस् राहत, दुःख, चिन्ता वा रिस सँगै आउन सक्छन्, र घर भवनमात्र होइन भनेर बताउनुहोस् ।

भन्नुहोस् *"छिमेकी, काम र सम्झनाको याद आउनु यसैको भाग हो । यी कुरा गुमाउनु सानो कुरा होइन ।"*

सोध्नुहोस् *"यहाँका मानिसहरूलाई सबैभन्दा बढी केको याद आउँछ?"*

4 केले सहयोग गर्न सक्छ · ४ मिनेट · आवश्यकताअनुसार सामग्री बदल्दै

गर्नुहोस् पोस्टरको *"केले सहयोग गर्न सक्छ"* हेर्नुहोस् । तपाईंले जाँच गरेको स्थानीय जानकारी मात्र बताउनुहोस् ।

सोध्नुहोस् *"यो हप्ता जानकारीका लागि तपाईं कसलाई सोध्नुहुन्छ? चेतावनी आयो भने के गर्नुहुन्छ?"*

5 बुझाइ जाँच्ने र समापन · ३ मिनेट · राख्नका लागि पर्चा दिनुहोस्

गर्नुहोस् पर्चा दिनुहोस् र *"तपाईंले एक्लै सम्हाल्नुपर्दैन"* र सहयोग सन्देशहरू देखाउनुहोस् । सत्रपछि तपाईंलाई कहाँ भेट्न सकिन्छ भनेर बताउनुहोस् ।

सोध्नुहोस् *"आज कसैलाई सहयोग चाहिएमा उहाँ कहाँ जान वा कसलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ?"*

सुरक्षा, प्रेषण र कार्यकर्ताका सीमाहरू

कसैमा यी कुरा देखिए अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस्:

संकेतहरू

- आत्महत्याको, वा आफूलाई वा अरूलाई हानि पुऱ्याउने कुरा गर्छ
- आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन, वा आफ्नो जिम्मामा रहेको बच्चाको हेरचाह गर्न सक्दैन
- धेरै अलमलमा परेको देखिन्छ, वा आफू कहाँ छ भन्ने थाहा पाउँदैन

के गर्ने

1. त्यो व्यक्तिसँगै बस्नुहोस् । उहाँलाई एक्लै नछोड्नुहोस् ।
2. अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस्: यस क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, उद्धारकर्मी वा आपतकालीन सेवा ।
3. आत्महत्याबारे सिधै सोध्नु ठीक हो । सोध्दैमा उहाँको मनमा त्यो विचार आउँदैन ।
4. स्वास्थ्यकर्मी वा उद्धारकर्मीले जिम्मा नलिँदासम्म साथमै रहनुहोस् । अलि शान्त महसुस हुनु अन्तिम बिन्दु होइन ।

कोही विचलित भएमा

- शान्त रहनुहोस् र नजिकै बस्नुहोस् ।
- उहाँ चाहनुहुन्छ भने समूहबाट टाढा अलि शान्त ठाउँ दिनुहोस् ।
- बोल्न कर नगर्नुहोस् । अहिले उहाँलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्नुहोस् ।
- उहाँ चाहनुभएसम्म, वा उहाँले विश्वास गर्ने कोही साथमा नआएसम्म बस्नुहोस् ।

PFA: हेर्ने, सुन्ने र जोड्ने

हेर्ने: सुरक्षा, तत्काल आवश्यकता, अत्यन्त विचलित मानिसहरू
सुन्ने: आवश्यकता र चिन्ताबारे सोध्ने; शान्त हुन सहयोग गर्ने
जोड्ने: आधारभूत आवश्यकता, सेवा, जानकारी, आफन्त

यस्तो भएमा निजी रूपमा कुरा गर्नुहोस् र थप सहयोगसँग जोड्नुहोस्

- भावनाहरू झन् गाह्रा हुन्छन्, सुधार हुँदैनन्, वा दैनिक जीवन धेरै कठिन बनाउँछन्
- आफ्नो वा आफ्ना बालबालिकाको हेरचाह गर्न सक्नुहुन्न
- शरीरको कुनै समस्याले चिन्तित बनाएको छ: दुखाइ, ज्वरो, चोटपटक, वा धेरै दिनसम्म खान वा सुत्न नसक्नु
- व्यावहारिक आवश्यकता पूरा भएका छैनन्: खाना, पानी, बास, औषधि वा हेरचाह । सम्बन्धित सेवासँग सम्पर्क गर्न सघाउनुहोस्; यसलाई मानसिक स्वास्थ्यको समस्या नठान्नुहोस्

उहाँको सहमतिमा: विकल्पहरू बताउनुहोस्, सकेमा साथै जानुहोस्, र आवश्यक कुरा मात्र अरूलाई बताउनुहोस् ।

✓ गर्नुहोस्

- ✓ सरल शब्द प्रयोग गर्नुहोस् र मौनताको सम्मान गर्नुहोस्
- ✓ जाँच गरिएको स्थानीय जानकारी मात्र दिनुहोस्
- ✓ हरेक परिवारको आफ्नै निर्णयको सम्मान गर्नुहोस्
- ✓ सोध्ने जोकोहीसँग पछि निजी रूपमा कुरा गर्नुहोस्

✗ नगर्नुहोस्

- ✗ आवास, पैसा वा मितिको वाचा नगर्नुहोस्
- ✗ परिवारलाई घर फर्कनुपर्छ कि पर्दैन भनेर नभन्नुहोस्
- ✗ मानिसहरूलाई आफूले गुमाएका कुराबारे बोल्न दबाब नदिनुहोस्
- ✗ आफूले जाँच नगरेको जानकारी अरूलाई नबताउनुहोस्

यस क्षेत्रका सहयोग सम्पर्कहरू कुराकानी अघि भर्नुहोस् र जाँच्नुहोस्

स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्था _____

तत्काल सहयोग _____

घरको सुरक्षा जाँच _____

सहायतासम्बन्धी जानकारी _____

चेतावनी र सुरक्षित ठाउँ _____



स्रोतहरू: WHO, Psychological First Aid: Guide for Field Workers (2011); IASC, Guidelines on MHPSS in Emergency Settings (2007), Action Sheets 8.1–8.2; IFRC Psychosocial Centre, Mental health and psychosocial impacts of flooding । यो सामग्री यी प्रकाशनहरूमा आधारित छ; यसलाई WHO, IASC वा IFRC ले तयार गरेका होइनन्, र तिनीहरू यसको विषयवस्तुका लागि जिम्मेवार छैनन् ।

यो सामग्री केका बारेमा हो

पोस्टर र पर्चामा दैनिक बोलचालका शब्द प्रयोग गरिएको छ, ताकि मानिसहरूले क्लिनिकल नाम नदिई घर फर्कने, सर्ने वा पर्खनेबारे कुरा गर्न सकून् । यो पृष्ठले ती शब्दहरूको पछाडिको अर्थ र तपाईंको भूमिकाका सीमाहरू बताउँछ; पृष्ठ ४ मा सन्दर्भका लागि मात्र क्लिनिकल शब्दहरू छन् ।

शब्द कुञ्जी

पोस्टर वा पर्चामा	हाम्रो अर्थ	कुराकानीमा कसरी सम्हाल्ने
***"हरेक परिवारको अर्को कदम फरक हुन्छ"*: घर फर्किँदै, नयाँ ठाउँमा सर्दै, अझै पर्खँदै**	घर फिर्ती, पुनर्वास र निरन्तर विस्थापन, सबै मान्य परिणाम	बाटाहरूलाई राम्रो-नराम्रो भनेर क्रम नदिनुहोस्, वा परिवारलाई कुन छान्ने भनेर सल्लाह नदिनुहोस्
"घर भनेको घरको भवनमात्र होइन"	घर, ठाउँ, समुदाय र जीविकोपार्जनको क्षति, जसको शोक हुन सक्छ	यी क्षतिलाई स्वीकार गर्नुहोस्; घर अझै उभिएको छ भनेर तिनलाई सानो नठान्नुहोस्
"जाँच गरिएको जानकारी माग्नुहोस्"*; *"ताजा जानकारी सोध्नुहोस्"	सही र समयमै पाइने जानकारीले पीडा कम गर्छ; अनिश्चितता आफैंमा तनावको कारण हो	पुष्टि गरिएको जानकारी मात्र बताउनुहोस्; आवास, पैसा वा मितिको कहिल्यै वाचा नगर्नुहोस्

सरेपछिका भावनाहरू, र कहिले थप हेर्ने

सामान्य भावनाहरू

राहत, दुःख, चिन्ता वा रिस, कहिलेकाहीँ सबै एकैसाथ । छिमेकी, काम, परिचित ठाउँ र सम्झनाहरूको याद आउनु । अब के हुन्छ भन्ने थाहा नहुनु आफैंमा गाह्रो हो ।

समयमै सहयोग, जुनसुकै बेला

भावनाहरू झन् गाह्रा भएमा, नहटेमा, वा दैनिक जीवन कठिन बनाएमा, त्यो व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहोस् । उहाँले पर्खनुपर्दैन ।

अहिले नै सहयोग लिनुहोस्

खतरा छ भने तुरुन्तै पृष्ठ २ पालना गर्नुहोस्: त्यो व्यक्तिसँगै बस्नुहोस् र तत्काल सहयोग लिनुहोस् ।

यी कुरालाई छुट्टै राख्नुहोस्

- **व्यावहारिक आवश्यकताहरू** (खाना, बास, कागजात वा पैसा) सेवासँग जोडिन्छन्, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाका रूपमा बुझिँदैनन् ।
- **क्षति र अनिश्चितताबाट हुने पीडा** सामान्य प्रतिक्रिया हो, रोग होइन ।
- **निदानले** दैनिक जीवनमा बाधा पुऱ्याउने लामो समयसम्म रहने ढाँचा बताउँछ, जसको मूल्याङ्कन तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्छन् ।

तपाईंका सीमाहरू

- परिवारलाई घर फर्कने, सर्ने वा पर्खने भनेर तपाईं सल्लाह दिनुहुन्न ।
- तपाईं आवास, पैसा वा मितिको वाचा गर्नुहुन्न ।
- तपाईंले जाँच गरेको जानकारी मात्र बताउनुहुन्छ । घरको जाँच कसले गर्छ र सहायता कसले हेर्छ भन्ने स्थानीय रूपमा पुष्टि गरिन्छ ।

तपाईंको भूमिका



यो निर्देशिकाले सत्र सञ्चालनमा सहयोग गर्छ; यसले मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचारको तालिमको ठाउँ लिँदैन । आफ्नो तालिम, सुपरिवेक्षक र थाहा भएका प्रेषणका बाटो प्रयोग गर्नुहोस् ।

आफ्नो पनि ख्याल राख्नुहोस्: विश्राम लिनुहोस्, आफ्ना सुपरिवेक्षक वा सहकर्मीसँग कुरा गर्नुहोस्, र चाहिएको बेला सहयोग माग्नुहोस् ।

अर्को कदमबारे निजी रूपमा कुरा गर्दा

- आफ्नो परिचय दिनुहोस् र अनुमति लिनुहोस् । तपाईं के दिन सक्नुहुन्छ र के सक्नुहुन्न भनेर बताउनुहोस् ।
- उहाँले छानेको एउटा आवश्यकतामा सहयोग गर्नुहोस्: जाँच गरिएको जानकारी, कुनै व्यावहारिक सेवा, वा उहाँले विश्वास गर्ने मानिस ।
- सम्भव र चाहिएको भए मात्र पछिको भेटघाट तय गर्नुहोस्; गर्न नसक्ने भेट वा फोनको वाचा नगर्नुहोस् ।
- व्यक्तिलाई केको याद आउँछ र सबैभन्दा बढी केको चिन्ता छ भनेर सुन्नुहोस् । यी कुरा गुमाउनु सानो कुरा होइन ।
- औषधि हराएको वा सकिन लागेको छ भने सुरक्षित रूपमा निरन्तर राख्न स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहोस् ।

स्रोतहरू: WHO, Psychological First Aid: Guide for Field Workers (2011); IASC, Guidelines on MHPSS in Emergency Settings (2007), Action Sheets 8.1–8.2; IFRC Psychosocial Centre, Mental health and psychosocial impacts of flooding ।

तपाईंले सुन्न सक्ने क्लिनिकल शब्दहरू

सन्दर्भका लागि मात्र । यी शब्द सहभागीहरूसँग प्रयोग नगर्नुहोस्, र निदान नगर्नुहोस् । स्वास्थ्यकर्मीले के भन्न सक्छन्, र व्यावहारिक सहयोग किन पहिले आउँछ भनेर बुझ्न यसले सघाउँछ ।

शब्द वा अवस्था	सहजकर्ताले जान्नुपर्ने कुरा	स्रोत
विस्थापन र अनिश्चितताको तनाव	घर, ठाउँ र जीविकोपार्जनको क्षति, र अब के हुन्छ भन्ने थाहा नहुनु, निरन्तर रहने ठूला तनावका कारण हुन् । सही जानकारी र व्यावहारिक सहयोगले पीडा कम गर्छ ।	IFRC Psychosocial Centre, Mental health and psychosocial impacts of flooding; IASC (2007)
Adjustment disorder (समायोजन विकार)	पहिचान गर्न सकिने तनावको कारणप्रतिको असमायोजित प्रतिक्रिया, जुन सामान्यतया एक महिनाभित्र देखा पर्छ र तनावको कारण रहिरहेन भने प्रायः छ महिनाभित्र हट्छ । मानिसलाई नाम नदिनुहोस्; तनावका कारण जारी रहेका ठाउँमा व्यावहारिक सहयोग पहिले आउँछ । तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले मात्र मूल्याङ्कन गर्छन् ।	WHO, ICD-11, 6B43
व्यावहारिक आवश्यकता मानसिक स्वास्थ्यका समस्या होइनन्	खाना, बास, कागजात वा पैसाको अभाव सेवासँग जोडिन्छ, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाका रूपमा व्याख्या गरिँदैन ।	IASC, Guidelines on MHPSS in Emergency Settings (2007)
***"ट्रमा"*, सहभागीले यो शब्द प्रयोग गर्दा**	शब्द नसच्याउनुहोस् र ट्रमाबारे छलफल सुरु नगर्नुहोस् । उहाँको अर्थ के हो भनेर सोध्नुहोस्: *"तपाईंले ट्रमा भन्नुहुँदा के भन्न खोज्नुभएको हो? आफूमा के देख्नुहुन्छ?"* मानिसहरूले प्रायः यो शब्द कुनै खास डर वा परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्छन्, जस्तै *"फेरि त्यस्तै होला भनेर घर फर्कन डर लाग्छ"* । यस्तो डर डरलाग्दो वा आघात पुऱ्याउन सक्ने अनुभवपछिको सामान्य प्रतिक्रिया हो । व्यक्तिले बताएको कुरामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्, र यो लामो समय रहिरहे, झन् बढे वा दैनिक जीवन कठिन बनाए समयमै सहयोगको बाटो प्रयोग गर्नुहोस् ।	यो शृङ्खलाको सहजीकरण अभ्यास; सुन्ने तरिका WHO, Psychological First Aid (2011) अनुसार

अभ्यास कार्डहरू

मानिसहरूले के भन्न सक्छन् र तपाईं चरणबद्ध रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उदाहरणहरू । यी कुराकानी समूहका अगाडि होइन, निजी रूपमा हुन्छन् । शब्दहरू उदाहरण मात्र हुन्: आफ्नै शब्द प्रयोग गर्नुहोस्, व्यक्तिको इच्छाअनुसार अघि बढ्नुहोस्, र कुनै तत्काल संकेत देखिएमा तुरुन्तै पृष्ठ २ प्रयोग गर्नुहोस् ।

तपाईंले भन्ने वा सोध्ने शब्दहरू · व्यक्तिले भन्न सक्ने कुरा · तपाईंका लागि निर्देशन (सादा अक्षर)

कसैले "ट्रमा" भनेमा

"मलाई ट्रमा छ । म आफ्नो घर फर्कन सक्दिनँ ।"

पोस्टर: घर फर्कंदा, सुरक्षित भएपछि मात्र फर्कनुहोस् ।

1 उहाँको अर्थ सोध्नुहोस्

सोध्नुहोस् — *"तपाईंले ट्रमा भन्नुहुँदा के भन्न खोज्नुभएको हो? आफूमा के देख्नुहुन्छ?"*

उहाँ भन्नुहुन्छ — *"घर नजिक पुग्दा मेरो मुटु ढुकढुक गर्छ । फेरि त्यस्तै होला भन्ने लागिरहन्छ ।"*

2 यसलाई सामान्य भनेर बुझाउनुहोस्

भन्नुहोस् — *"डरलाग्दो घटना भएको ठाउँ नजिक डर लाग्नु सामान्य प्रतिक्रिया हो ।"*

3 डर र सुरक्षालाई छुट्टै राख्नुहोस्

गर्नुहोस् — घरको सुरक्षा जाँच भएको छैन भने अझै भित्र नपस्ने सल्लाह नै लागू हुन्छ । यस क्षेत्रमा घरको जाँच कसले गर्छ भनेर पत्ता लगाउन सघाउनुहोस् ।

4 कहिले थप हेर्ने भनेर जान्नुहोस्

गर्नुहोस् — डर झन् बढेमा, नहटेमा, वा दैनिक जीवन कठिन बनाएमा, त्यो व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहोस् । उहाँले पर्खनुपर्दैन ।

परिवारले तपाईंलाई निर्णय गर्न भन्दा

"हामी घर फर्कौं कि यहीं बसौं? तपाईं नै भन्नुहोस् ।"

पोस्टर: हरेक परिवारको अर्को कदम फरक हुन्छ ।

1 उहाँहरूका लागि निर्णय नगर्नुहोस्

भन्नुहोस् — *"यो तपाईंको परिवारको निर्णय हो । तपाईंले निर्णय गर्न सक्नुहोस् भनेर म जाँच गरिएको जानकारी खोज्न सघाउन सक्छु ।"*

2 निर्णय गर्न के थाहा हुनुपर्छ पत्ता लगाउनुहोस्

सोध्नुहोस् — *"निर्णय गर्न तपाईंलाई के थाहा हुनुपर्छ? कसलाई सोध्न सक्नुहुन्छ?"*

3 जाँच गरिएको जानकारीसँग जोड्नुहोस्

गर्नुहोस् — घरको जाँच, सहायता वा चेतावनीका लागि जाँच गरिएका सम्पर्क मात्र दिनुहोस् । आवास, पैसा वा मितिको कहिल्यै वाचा नगर्नुहोस् ।

पर्खाइ कहिल्यै नसकिनेजस्तो लाग्दा

"कसैले केही भन्दैन । हामी हप्तौंदेखि पर्खिरहेका छौं ।"

पर्चा: अझै पर्खंदै ।

1 स्वीकार गर्नुहोस्

भन्नुहोस् — *"अब के हुन्छ भन्ने थाहा नहुनु गाह्रो हो ।"*

2 सँगै प्रश्नहरू तयार गर्नुहोस्

गर्नुहोस् — आश्रयस्थलका जिम्मेवार व्यक्ति वा वडा कार्यालयलाई सोध्न सघाउनुहोस्: *"के थाहा छ? के अझै तय भएको छैन? फेरि कहिले सोध्न सक्छु?"*

3 व्यावहारिक आवश्यकता जाँच्नुहोस्

सोध्नुहोस् — *"आज खाना, पानी वा औषधिजस्ता केही कुराको अभाव छ?"*

गर्नुहोस् — सम्बन्धित सेवासँग सम्पर्क गर्न सघाउनुहोस्; व्यावहारिक आवश्यकतालाई मानसिक स्वास्थ्यको समस्या नठान्नुहोस् ।